（五）急性右室梗死

	急性左室梗死合并急性左心衰	急性右室梗死合并急性右心衰
	PCWP↑,CI↓	PCWP↓或正常,CI↓
首要关键治疗：	PCI	补液
根本关键治疗：	PCI	PCI
利尿,硝酸酯类	√	×
多巴酚丁胺	√	√
强心苷	×	×

①**多与下壁、后壁心梗同时出现**

②**一开始即出现右心衰表现：颈静脉怒张等**

③CVP↑、PAWP↓或正常　右心梗→右心房压力↑→CVP↑;右心梗往肺循环射血↓

④**补充血容量（关键）**，多巴酚丁胺（β1-R激动剂），再灌注治疗等　把右心室看成通往左心的一根血管

⑤**禁用**一切减少回心血量的药如**利尿剂、硝酸酯类**（水泵变水管）

要看什么原因导致右心衰,再决定治疗

单纯右心衰就用利尿剂,右心梗要补液

（右心梗可以合并右心衰）

肺心病在控制感染改善呼吸后右心功能没有明显改善才用利尿剂(小剂量,作用温和的氢氯噻嗪+螺内酯)

六、冠心病的检查

（一）冠脉 CTA

冠脉 CTA 未见狭窄病变者、一般可以不进行冠脉造影 DSA、冠脉内超声等有创检查　这样可以避免做有创检查

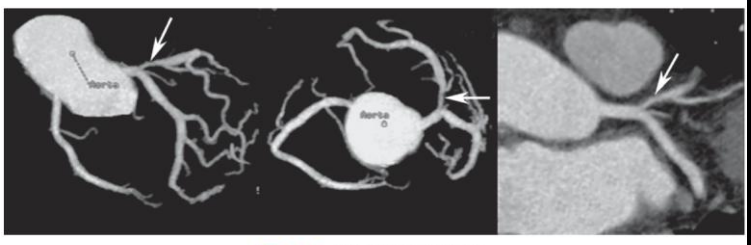


图 3-4-6　多层螺旋 CT 冠脉成像

箭头所示为左前降支近段病变,左、中、右图为不同角度所示。



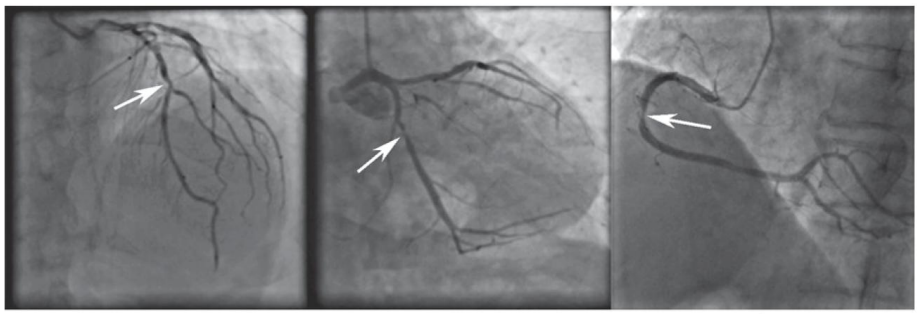
重建

肺栓塞:金标准DSA

首选CTPA

（二）冠脉造影 DSA 诊断冠心病的金标准





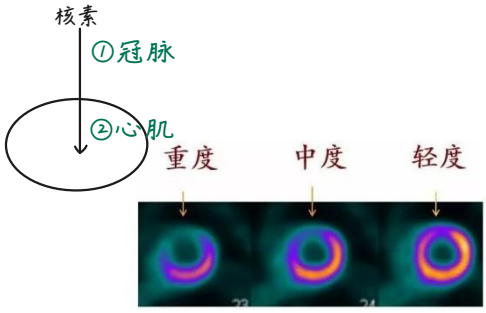
A　B　C

图 3-4-8　选择性冠脉造影显像

A. 正头位（AP+CRA 30°），箭头所示为左前降支中段的病变部位；B. 右前斜足位（RAO 30°+CAU 30°），箭头所示为左回旋支近中段的病变部位；C. 左前斜位（LAO 45°），箭头所示为右冠状动脉中段病变部位。

（三）放射性核素心肌显像

灌注缺损显示缺血或梗死区域（瘢痕）　心肌细胞能否摄取核素受①冠脉（血管）状态②心肌细胞状态影响



（四）放射性核素心腔造影

可测定左心室射血分数，显示心肌缺血区的室壁呈节段性运动障碍

普遍弥漫性运动障碍-扩心病

（五）PET

可判断心肌血流灌注和心肌代谢，因此能准确评估心肌活力

细胞病变过程:细胞代谢出问题→功能出问题→形态出问题

超声、X线、CT

代谢→功能→形态

PET　磁共振